콜레스테롤이 정상인데 왜 심장이 위험할까요?

잘 알려지지 않은 심혈관 위험인자 — 지질단백질(a), 즉 Lp(a) 이야기

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

보통 콜레스테롤 검사에 나오지 않습니다

지질단백질(a)은 별도의 혈액검사로 확인합니다

어떤 물질인가요

나쁜 콜레스테롤 입자에 단백질이 하나 더 붙은 형태입니다. 일반 콜레스테롤과 비슷해 보여도 별도로 살펴야 합니다.

어떻게 아나요

일반 콜레스테롤 검사에는 포함되지 않아 따로 측정합니다. 검사표에 이 항목이 없으면 수치를 알 수 없습니다.

왜 알아두나요

높으면 심장 혈관 위험을 판단할 때 중요한 단서가 됩니다. 다른 위험요인과 함께 보아야 결과를 바르게 해석할 수 있습니다.

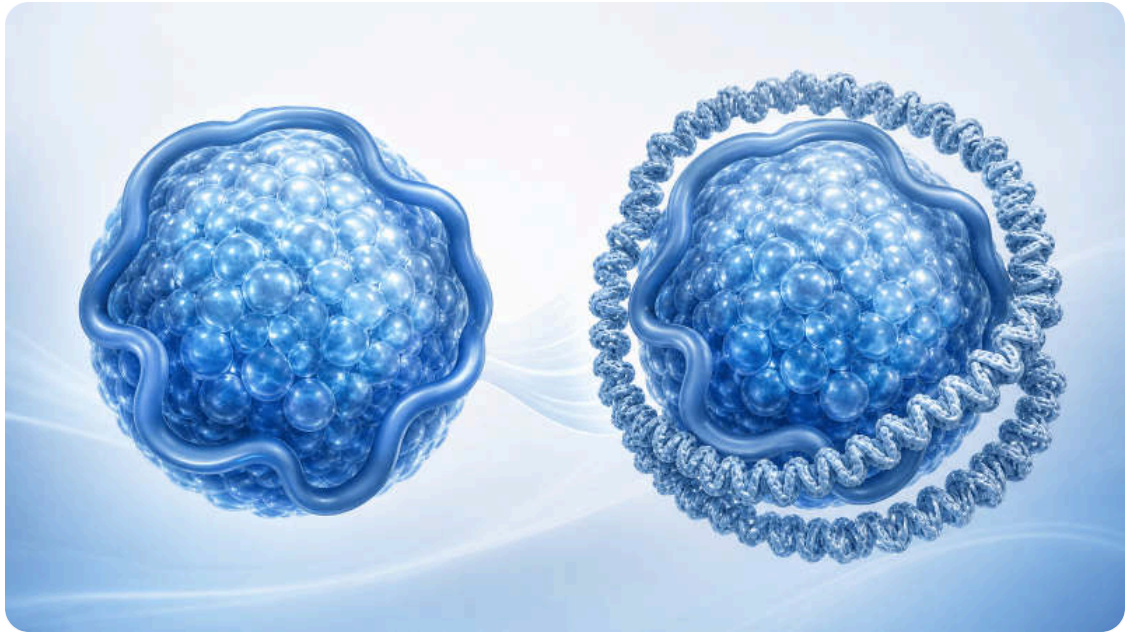


그림 · 모양이 비슷해도 검사 항목은 다릅니다.

농도는 주로 유전으로 정해져 비교적 일정합니다.

근거 · AHA·EAS 2022 지질단백질(a) 자료 · VESALIUS-CV, Circulation 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

높을수록 심장 혈관 위험이 커질 수 있습니다

한 연구에서는 심근경색 등 심장 사건과의 관련이 뚜렷했습니다

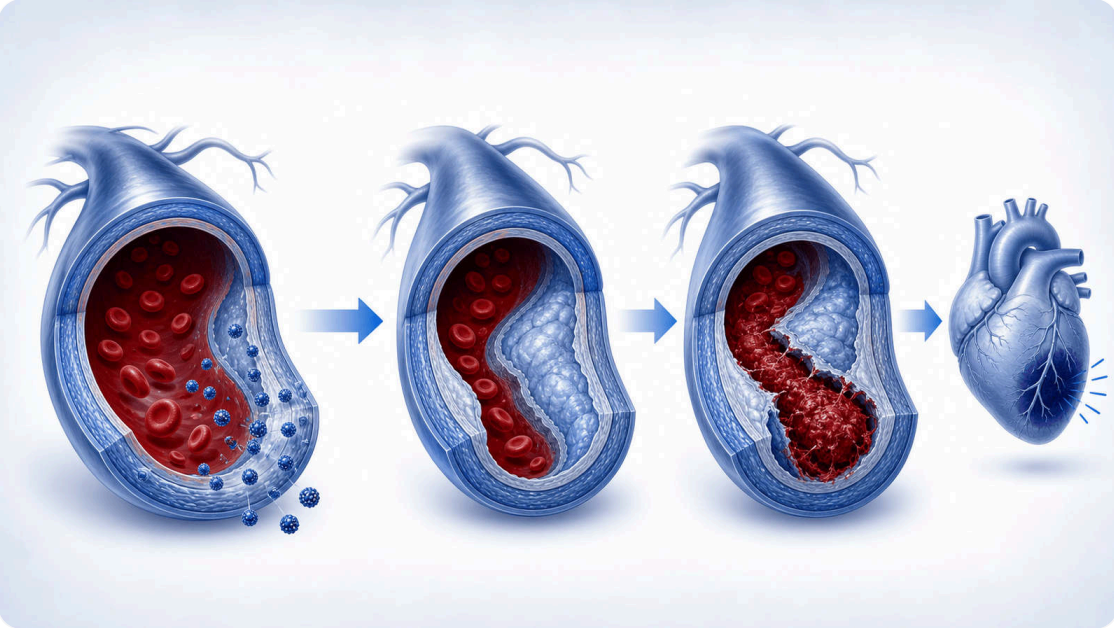


그림 · 혈액검사 결과는 다른 위험요인과 함께 해석합니다.

심장 혈관

지질단백질(a)이 높을수록 심근경색 등 관상동맥 사건이 늘었습니다. 이 연구에서는 심장 혈관과의 관련이 특히 뚜렷했습니다.

뇌졸중 해석

이 연구에서는 허혈성 뇌졸중과 뚜렷한 관련이 보이지 않았습니다. 뇌졸중과 무관하다고 결론내릴 수는 없으며 다른 연구까지 모두 부정하는 뜻도 아닙니다.

한 연구의 뇌졸중 결과를 모든 사람에게 일반화하지 않습니다.

근거 · AHA·EAS 2022 지질단백질(a) 자료 · VESALIUS-CV, Circulation 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

고위험군 7,557명을 살펴봤습니다

심근경색이나 뇌졸중을 아직 겪지 않은 분들을 추적했습니다

7,557

검사한 사람

연구 시작 때 지질단백질(a)을 측정했습니다. 참가자는 아직 심근경색이나 뇌졸중을 겪지 않은 고위험군이었습니다.

고위험군 연구

4.6년

관찰 기간

참가자를 추적한 기간의 중앙값입니다. 연구진은 그동안 심장 혈관 사건이 생기는지 살폈습니다.

긴 기간 관찰

예방 대상

첫 심근경색·뇌졸중을 막는 치료를 살폈습니다. 이미 병을 겪은 분의 재발 예방과는 구분해 읽어야 합니다.

이미 병을 겪은 분과 구분

이 연구의 결과는 참여한 고위험군의 특성을 고려해 읽어야 합니다.

근거 · AHA·EAS 2022 지질단백질(a) 자료 · VESALIUS-CV, Circulation 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강한 콜레스테롤 치료는 양쪽 모두에 도움됐습니다

지질단백질(a)이 높든 낮든 심장 사건이 줄었습니다

높은 그룹

주사 치료를 받은 그룹에서 주요 관상동맥 사건이 약 41% 감소했습니다. 이 수치는 지질단백질(a)이 높은 그룹의 결과입니다.

낮은 그룹

같은 치료를 받은 그룹에서도 약 35% 감소했습니다. 지질단백질(a)이 낮아도 치료 이득이 관찰됐습니다.

숫자의 차이

두 그룹의 감소율 차이만으로 어느 쪽에 약이 더 잘 듣는다고 단정할 수 없습니다. 두 그룹 모두 이득이 있었다는 점이 중요합니다.

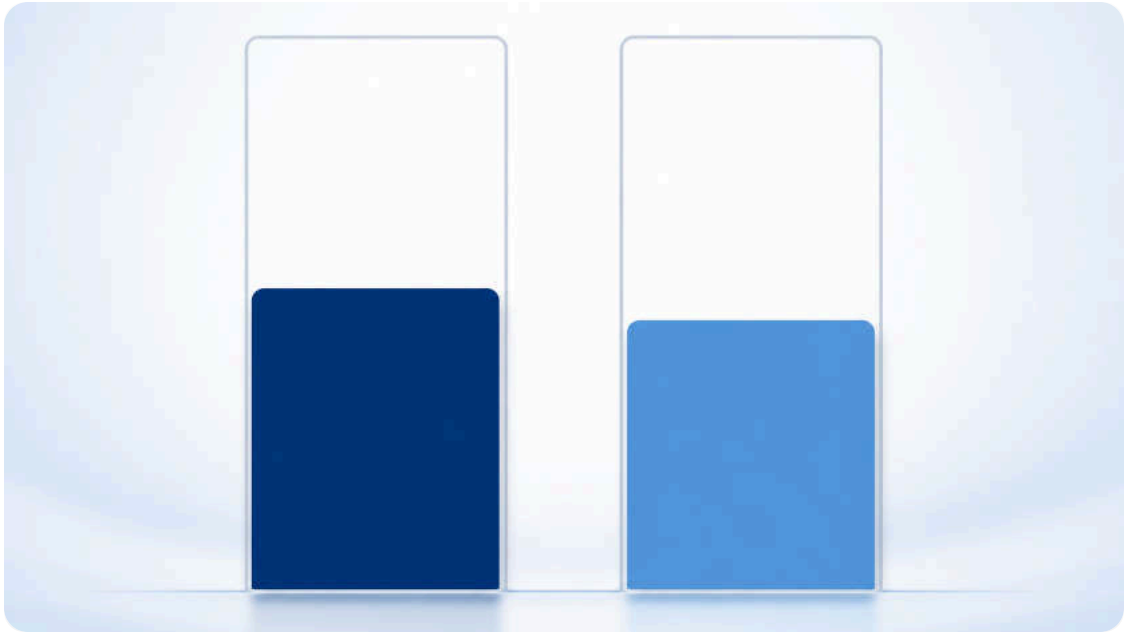


그림 · 두 그룹 모두에서 이득이 관찰됐습니다.

두 그룹을 비교한 추가 분석의 한계가 있습니다.

근거 · AHA·EAS 2022 지질단백질(a) 자료 · VESALIUS-CV, Circulation 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

높은 사람에게만 약이 더 잘 듣는 것은 아닙니다

두 그룹의 차이는 우연일 가능성을 배제할 수 없었습니다

확인된 내용

지질단백질(a)이 높든 낮든, 나쁜 콜레스테롤을 낮추는 주사 치료를 받은 양쪽 그룹에서 심장 사건이 줄었습니다.

- 지질단백질(a)이 높은 그룹에서도 사건 감소
- 지질단백질(a)이 낮은 그룹에서도 사건 감소
- 두 그룹 모두 나쁜 콜레스테롤을 낮추는 주사 치료를 받았고 심장 사건이 줄었음

vs

확인되지 않은 내용

두 그룹의 감소율만 나란히 놓고 한쪽에 약이 더 잘 듣는다고 단정하지 않습니다. 추가 연구가 필요합니다.

- 지질단백질(a)이 높은 그룹에만 약이 특별히 더 잘 듣는다는 결론
- 지질단백질(a)을 직접 낮춰서 사건이 줄었다는 결론
- 검사 수치만으로 모든 환자에게 같은 치료가 필요하다는 결론

검사 결과 하나만으로 약을 정하지 않고 혈압·당뇨·흡연 등 전체 심혈관 위험을 함께 봅니다.

근거 · AHA·EAS 2022 지질단백질(a) 자료 · VESALIUS-CV, Circulation 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사 결과를 알고 조절 가능한 위험을 관리하세요

유전으로 정해지는 수치보다 바꿀 수 있는 요인에 집중합니다

01 지질단백질(a)은 일반 콜레스테롤 검사와 별도로 확인합니다

02 주로 유전으로 정해지는 수치여서 평생 비교적 일정하고 보통 한 번 확인합니다

03 수치가 높다면 혈압을 잘 관리하고 다른 심장 혈관 위험도 함께 살핍니다

04 나쁜 콜레스테롤을 낮추는 치료를 꾸준히 받으며 임의로 중단하지 않습니다

05 흡연과 당뇨 등 조절 가능한 다른 위험요인도 함께 살핍니다

06 검사 수치 하나만 보지 말고 담당 의사와 전체 위험을 함께 해석합니다

뇌졸중과 무관하다고 안심할 근거로 쓰지 마세요.

근거 · AHA·EAS 2022 지질단백질(a) 자료 · VESALIUS-CV, Circulation 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

VESALIUS-CV 연구로 지질단백질(a)과 심혈관 위험을 설명하는 자료입니다. 내 수치 읽는 법은 지질단백질(a)·아포B 결과 안내문, 자세한 설명은 지질 검사 설명 자료를 봅니다.

참고한 자료

AHA·EAS 2022 지질단백질(a) 자료 · VESALIUS-CV, Circulation 2026

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요